[redacted]
SALUD PÚBLICA PARA PSICÓLOGOS

EJE 05 · PSICOLOGÍA

Gestión de Servicios de Salud

Organizar recursos, redes y equipos para producir atención oportuna, segura y continua.



05	16	7.ª
EJE OFICIAL	TEMAS DESARROLLADOS	EDICIÓN · OCT. 2026

Contenido y diseño [redacted]

[redacted] conservan sus licencias

EJE 05 · MAPA DE ESTUDIO

Tu ruta por el eje

Organizar recursos, redes y equipos para producir atención oportuna, segura y continua.

01

Planeamiento y organización

La gestión conecta políticas y necesidades con objetivos, estructura, procesos, recursos e indicadores.

6 TEMAS

02

Red

La contin
moment
ursos disponibles en el

6 TEMAS

03

Personas, liderazgo y calidad

Los resultados dependen de alianzas, equipos, cultura y aprendizaje continuo.

4 TEMAS

RUTA DE USO

01 **COMPRENDE**
Relaciona ideas

02 **RECUPERA**
Explícalo sin mirar

03 **PRACTICA**
Corrige tus errores

conservan sus licencias

01

Planeamiento y organización

La gestión conecta políticas y necesidades con objetivos, estructura, procesos, recursos e indicadores.

EN ESTE RECORRIDO

01 **Planeamiento estratégico** … **res y FODA**

03 **PEI y POI** … **ización funcional**

05 **Categorías de establecimien** … **servicios**

OBJETIVO DEL CAPÍTULO

Revisa la ruta, explica cada tema con tus palabras y después practica con casos.

conservan sus licencias

TEMA 01 · EJE 05

Planeamiento estratégico y marco legal

El planeamiento institucional es una cadena: las políticas y planes de mayor nivel orientan el PEI, y este se ejecuta mediante el POI. Diagnóstico, objetivos, acciones, recursos, indicadores, seguimiento y evaluación deben ser coherentes. Si una actividad consume recursos pero no contribuye a una acción estratégica, el problema no es solo documental: se pierde dirección institucional.

CICLO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. Análisis de la situación actual: comprender el territorio o entidad, sus problemas, brechas y capacidades mediante evidencia.

2. Análisis prospectivo: explorar tendencias, riesgos, oportunidades, escenarios y aspiraciones.

3. Decisión estratégica: definir jetivos y acciones estratégicas para alcanzarla.

4. Seguimiento y evaluación: r es para retroalimentar las decisiones.

Diagnosticar lo que ocurre cor s, a la fase 3. Prospectiva no es ejecutar actividades. El ciclo stes durante la implementación.

Fuentes: [R047] Directiva N.° 001-2024-CE 24 (30/04/2024), art. 13.2 · [R048] RPC N.° 055-2024/CEPLAN/PCD (13/06/2024), 57-2025/CEPLAN/PCD (25/06/2025), modificación de la Directiva001-2024

ANCLAS PARA RECOR

01	El PEDN orienta el desarrollo nacional; los planes sectoriales y territoriales traducen esa dirección en su ámbito.
02	El PEI define la estrategia de la entidad y el POI organiza su ejecución operativa.
03	Las decisiones deben guardar coherencia con competencias, presupuesto y políticas vigentes.

CLAVE DE EXAMEN **PEI y POI deben estar alineados: estrategia sin operación no se ejecuta; operación sin estrategia dispersa recursos.**

Fuente: Guía para el Planeamiento Institucional actualizada 2024, CEPLAN.

conservan sus licencias

TEMA 02 · EJE 05

Misión, visión, valores y FODA

Misión explica razón de ser actual; visión describe futuro deseado; valores orientan conducta. FODA relaciona factores internos y externos.

FODA: ORIGEN DEL FACTOR

Factor	Origen	Ejemplo
Fortaleza	Interno favorable	Equipo competente
Debilidad	Interno desfavorable	Proceso sin estandarizar
Oportunidad	Externo favorable	Nueva alianza territorial
Amenaza	Ex	rmativo no implementado

ANCLAS PARA REC

01
Fortalezas y debilidades s zas provienen del

03
El análisis debe conducir a es

CLAVE DE EXAMEN **F y D = internas; O y A = externas.**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicología y bibliografía institucional vinculada.

conservan sus licencias

PEI y POI

La regla 5-3-1 resume los plazos vigentes: PEI de cinco años, POI Multianual de tres y POI Anual de uno. El primer año del POI Multianual pasa al POI Anual y se ajusta al PIA. Los dos años siguientes orientan la programación y se revisan cada año. Por eso «POI de 1 a 3 años» alude a dos instrumentos, no a un rango indistinto. El POI lleva las acciones del PEI a actividades e inversiones con metas, costos y responsables.

CONCEPTOS QUE SOSTIENEN EL TEMA

PEI
Plan Estratégico Institucional: define objetivos, acciones, indicadores y metas para un horizonte de cinco años.

POI Multianual
Programa actividades operativas e inversiones, metas físicas y costos para tres años dentro del PEI.

POI Anual
Concreta un año de actividade
recursos en consistencia con el
institucional de apertura.

Apertura con el que el POI
ncia.

PEI Y POI · REGLA 5-

Instrumento	Ho	
PEI	5 año	es estratégicas, as
POI Multianual	3 años	Actividades e inversiones, metas físicas y costos
POI Anual	1 año	Primer año ajustado al PIA para su ejecución
Relación	Revisión anual	El POI ejecuta las acciones del PEI; no son planes independientes

conservan sus licencias

Responsabilidad operativa y articulación

Concepto	Cómo reconocerlo	No confundir
Pregunta histórica	P46 de Psicología 2026-II: programación del POI, clave oficial C: unidad ejecutora.	Conservar esta respuesta al revisar el cuadernillo.
Trabajo institucional	Áreas y centros de costo programan actividades y necesidades conforme a sus funciones y al proceso institucional.	La clave no significa que una sola persona formule, apruebe y ejecute todo el POI.

Fuentes de esta ampliación: [E] MINSA · Cuadernillo oficial Psicología 2026-II

ANCLAS PARA RECORDAR

01	PEI: objetivos estratégicos institucionales, acciones estratégicas, indicadores y metas para lograr resultados.
02	POI Multianual: a sicas y costos por tres años dentro del period
03	POI Anual: primer institucional de apertura.
04	El POI Multianual tadores y se actualizan.
05	El POI puede mo idades, inversiones o presupuesto; la m ar alineamiento con el PEI.
06	El POI Multianual co umentos articulados, no plazos intercambiables.

CLAVE DE EXAMEN **No respondas solo «POI dura de 1 a 3 años»: especifica PEI = 5; POI Multianual = 3; POI Anual = 1.**

Fuente: Guía para el Planeamiento Institucional actualizada 2024, CEPLAN.

conservan sus licencias

Estrategia, operación e indicador: una cadena comprobable

Este ejemplo ficticio desarrolla la relación PEI-POI sin sustituir los instrumentos y reglas de CEPLAN.

Elemento	Ejemplo de estudio
Problema	Personas derivadas a evaluación que no completan la ruta.
Resultado buscado	Mejorar continuidad y acceso oportuno en la población definida.
Acción estratégica	Organizar coordinación, seguimiento e información para esa ruta.
Actividad operativa	Contactar, coordinar citas y verificar evaluación con responsables y recursos.
Indicador	Personas que completan evaluación en el plazo / personas derivadas elegibles × 100.
Ficha técnica	idad, responsable, línea de base y

EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVID

Eficacia: logro del efecto en co tado en condiciones reales.
Eficiencia: relación entre result efinición operativa del indicador utilizado.

No fijar metas sin línea de base con volumen: atender más personas no demuestra mejor aten guimiento identifica avances; la evaluación pregunta por resultad

Fuentes: [N18].

conservan sus licencias

TEMA 04 · EJE 05

ROF, MOP y organización funcional

El ROF formaliza la estructura orgánica de una entidad permanente con personería jurídica de derecho público. El MOP corresponde a programas, proyectos especiales u otras organizaciones dependientes previstas por los lineamientos y formaliza su estructura funcional. MOP significa Manual de Operaciones; no debe confundirse con el antiguo MOF ni utilizarse como documento de perfiles de puestos.

CONCEPTOS QUE SOSTIENEN EL TEMA

ROF
Reglamento de Organización y Funciones de una entidad permanente con personería jurídica de derecho público.

MOP
Manual de Operaciones que formaliza la estructura funcional de programas, proyectos especiales y ndientes previstas por los

Estructura orgánica
Distribución formal de órgano con niveles de autoridad y fun responsabilidades procesos de una

EL INSTRUMENTO CIÓN

Instrumento	¿A	
ROF	Entid jurídica de derecho público	a, funciones y organigrama
MOP	Programa, proyecto especial o entidad sin personería jurídica	Estructura funcional, funciones, procesos y relaciones
MOP	Órgano desconcentrado o académico, cuando corresponda	Dependencia y funcionamiento interno
No confundir	MOP ≠ antiguo MOF	Los puestos se regulan con instrumentos específicos

conservan sus licencias

ANCLAS PARA RECORDAR

01	ROF: estructura orgánica de entidades permanentes con personería jurídica de derecho público.
02	MOP: estructura funcional de programas, proyectos especiales y entidades sin personería jurídica; también órganos desconcentrados o académicos cuando corresponde.
03	Ambos incluyen funciones, relaciones y organigrama según los lineamientos aplicables.
04	El organigrama representa gráficamente unidades, niveles de autoridad y relaciones de línea o asesoramiento; no describe por sí solo procesos ni perfiles de puesto.
05	Los perfiles y responsabilidades de puestos se regulan mediante sus instrumentos específicos; no deben confundirse con ROF o MOP.

CLAVE DE EXAMEN **Pregunta clave: ¿la organización tiene personería jurídica y estructura org o dependiente?**

Fuente: Lineamientos de Organización del GP.

conservan sus licencias

Categorías de establecimientos

La categoría indica la capacidad resolutiva mínima que se espera de una IPRESS según sus recursos, organización, UPSS y Sub UPSS. I-1 a I-4 forman el primer nivel. II-1 y II-2 son generales; II-E es especializada. III-1 corresponde a atención general de alta complejidad, mientras III-2 y III-E son especializadas. El horario se revisa por servicio: Consulta Externa puede tener una programación propia, pero Emergencia, Hospitalización, parto y otros servicios críticos requieren continuidad. El horario fijado para una IPRESS concreta no se convierte automáticamente en el mínimo de toda la categoría.

CONCEPTOS QUE SOSTIENEN EL TEMA

Nivel de atención
Forma de ordenar la oferta san de un nivel que expresa la severidad de necesidades y ca mínima esperada del

Capacidad resolutiva
Aptitud para responder a nece anencia temporal; no recursos humanos, tecnológic zación del segundo y tercer disponibles.

PRIMER NIVEL · UP

Cat.	UPSS mínimas / Sub UP		Horario normativo
I-1	Consulta Externa	Uno o más profesionales de salud no médicos; técnico de enfermería según demanda	Se programa según demanda y recursos; sin mínimo numérico general
I-2	Consulta Externa	Con población asignada: médico, enfermería, obstetricia y técnico de enfermería	Consulta Externa: mínimo 6 h diarias
I-3	Consulta Externa + Patología Clínica	Dos o más médicos, odontología, enfermería, obstetricia; tecnólogo médico/biólogo y técnicos	Consulta Externa: mínimo 6 h; laboratorio diario según horario
I-4	Consulta Externa + Patología Clínica + Farmacia; Internamiento = Sub UPSS	Con población asignada: especialidades materno-infantiles, médico, odontología, enfermería, obstetricia, psicología, nutrición, farmacia y laboratorio.	Consulta Externa: mínimo 6 h; equipo de parto 24 h e internamiento continuo

conservan sus licencias

ATENCIÓN GENERAL · UPSS, PROFESIONALES Y COBERTURA

Cat.	UPSS mínimas	Profesionales clave	Horario / continuidad
II-1	Consulta Externa, Emergencia, Hospitalización, Centro Obstétrico y Quirúrgico; Rehabilitación, Imágenes, Patología Clínica, Farmacia, Hemoterapia, Nutrición y Esterilización	Medicina interna, gineco-obstetricia, cirugía, pediatría y anestesia; además medicina general, enfermería, obstetricia, psicología, odontología, nutrición, farmacia, tecnología médica y trabajo social	Consulta programada; Emergencia 24/365, Hospitalización y parto 24 h, cirugía de emergencia y apoyos críticos 24 h
II-2	UPSS de II-1 + UCI general y cuidados intermedios general/neonatal + Anatomía Patológica	Equipo de II-1 + cardiología, neurología, neumología, gastroenterología, psiquiatría, trauma/ortopedia, radiología, rehabilitación, cuidados intensivos y otras especialidades	Consulta por turnos; Emergencia, Hospitalización, UCI, parto y soporte crítico 24 h
III-1	UPSS de II-2 + especializadas, Hemodiálisis, R y Medicina Nu	des de irugía,	Consulta programada; Emergencia, Hospitalización, UCI y servicios críticos 24 h; otros por turnos

ATENCIÓN ESPECIA LÍNICO

Cat.	UPSS obligatori		Horario / continuidad
II-E	Consulta Exter Hospitalización, P Clínica, Farmacia y Nutrición; otras UPSS según campo clínico		Consulta programada; hospitalización continua y emergencia 24 h cuando corresponda al campo
III-E	UPSS de II-E + Diagnóstico por Imágenes; otras según campo clínico	Especialistas y subespecialistas relacionados con el campo clínico o grupo etario	Consulta por turnos; hospitalización y servicios críticos continuos según campo
III-2	UPSS de III-E + Investigación y Docencia; tecnología y soporte de máxima complejidad según campo	Una o más especialidades y todas las subespecialidades vinculadas al campo clínico o grupo etario	Consulta programada; hospitalización, emergencia y servicios críticos 24 h cuando correspondan

conservan sus licencias

Recategorización y capacidad resolutiva

Concepto	Cómo reconocerlo	No confundir
Periodicidad	La categoría tiene vigencia de 3 años; gestionar la recategorización según el procedimiento aplicable.	Una resolución antigua no demuestra vigencia actual.
Antes del plazo	Un cambio en capacidad resolutiva o complejidad puede motivar recategorización anticipada.	En P50 de 2026-II: clave B; no basta cambiar de jefe o recibir una petición política.

Fuentes de esta ampliación: [G] DIRESA Tacna · Recategorización · [E] MINSA · Cuadernillo oficial Psicología 2026-II

ANCLAS PARA RECORDAR

01	I-1: Consulta Externa; uno o más profesionales de salud no médicos. Su horario se programa según demanda y recursos, sin mínimo numérico general en la NTS.
02	I-2: Consulta Exte , enfermería, obstetricia y técnico de enfer
03	I-3: Consulta Exte ología, enfermería, obstetricia y técni
04	I-4: añade Farmac n asignada incluye psicología y equi quipo materno-neonata
05	II y III: Consulta E spitalización y otros servicios críticos campo clínico.

CLAVE DE EXAMEN **No memorices I-3 = 12 h o I-4 = 24 h como regla total: distingue horario de Consulta Externa y cobertura continua de los servicios críticos.**

Fuente: NTS N.° 021-MINSA/DGSP-V.03, con terminología modificada por RM N.° 625-2026-MINSA.

Fuentes: [R058] RM N.° 546-2011/MINSA (13/07/2011), NTS N.° 021-MINSA/DGSP-V.03, categoría I-4, pp.29-30 del anexo · [R059] RM N.° 625-2026/MINSA (15/07/2026), artículos 2-5 y 9

conservan sus licencias

TEMA 06 · EJE 05

UPSS y cartera de servicios

La cartera no es un catálogo aspiracional: reúne las prestaciones que el establecimiento puede brindar de forma efectiva con sus recursos, categoría y modalidades autorizadas. La NTS N.° 249 distingue UPS, UPSS y Sub UPSS, incorpora modalidad fija, móvil y telesalud, y ordena un ciclo de planificación, elaboración, aprobación, publicación, actualización y evaluación. El RENACSS permite registrar y transparentar las carteras.

CONCEPTOS QUE SOSTIENEN EL TEMA

UPS
Unidad Productora de Servicios: unidad básica con recursos humanos y tecnológicos para funciones homogéneas.

UPSS
UPS organizada para desarrollar funciones homogéneas y producir servicios de salud específicos.

Sub UPSS
Subunidad básica con recursos
taciones individuales y de
exclusivos; no constituye una
rindarse con capacidad

RENACSS
Repositorio Nacional de Carter
ifundir las carteras de
servicios.

conservan sus licencias

DE LOS RECURSOS DISPONIBLES A UNA CARTERA REALMENTE OPERATIVA

Concepto	Qué significa	Clave de examen
UPS	Unidad básica con recursos para funciones homogéneas	Es el concepto organizacional más amplio
UPSS	UPS organizada para producir servicios de salud específicos	Vinculada a cartera y nivel de complejidad
Sub UPSS	Subunidad con recursos compartidos o no exclusivos	Frecuente en primer nivel; no constituye UPSS
Cartera	Conjunto de prestaciones individuales y de salud pública disponibles	Debe corresponder a recursos y necesidades reales
Modalidad	Fija, móvil o telesalud	Una misma prestación puede brindarse por distintas modalidades
RENACSS	Re Se	las carteras aprobadas y
Ciclo	Pl pu	ona; no es una lista estática

conservan sus licencias

ANCLAS PARA RECORDAR

01	UPS es la unidad básica con recursos humanos y tecnológicos para funciones homogéneas; una UPSS es una UPS organizada para producir servicios de salud específicos.
02	Sub UPSS es una subunidad básica con recursos compartidos o no exclusivos; es frecuente en el primer nivel y no constituye una UPSS.
03	La cartera reúne prestaciones individuales y de salud pública realmente disponibles, según recursos y necesidades de la población.
04	Modalidades: fija, móvil y telesalud. La cartera de primer contacto corresponde a la puerta de entrada del primer nivel.
05	El catálogo de procedimientos estandariza nombres y códigos de procedimientos para registro y producción; la cartera comunica qué prestaciones puede brindar realmente la IPRESS. No son sinónimos.
06	Fases: planificació ublicación, actualización y evaluación; el RE ud.

CLAVE DE EXAMEN	**Una ure en una norma: req .**

Fuente: NTS N.° 249-MINSA/DGAIN-2026,

Fuentes: [R059] RM N.° 625-2026/MINSA (

conservan sus licencias

Categorías de establecimientos de salud

UPSS y actividades de atención directa y de soporte obligatorias · Estructura de la fuente conservada

	PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN (con población asignada)				SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN			TERCER NIVEL DE ATENCIÓN		
					Atención general		Atención especializada	Atención general	Atención especializada	
	I-1	I-2	I-3	I-4	II-1	II-2	II-E	III-1	III-E	III-2
ATENCIÓN DIRECTA	UPSS Consulta externa	UPSS Consulta externa	UPSS Consulta externa	UPSS Consulta externa	UPSS Consulta externa	UPSS Consulta externa	UPSS Consulta externa	UPSS Consulta externa	UPSS Consulta externa	UPSS Consulta externa
				Internamiento	UPSS Hospitalización	UPSS Hospitalización	UPSS Hospitalización	UPSS Hospitalización	UPSS Hospitalización	UPSS Hospitalización
	Atención de urgencias y emergencias				UPSS	UPSS		UPSS Emergencia		UPSS Emergencia
	Atención de parto			Atención de la gestante en el período de parto				UPSS Centro obstétrico		UPSS Centro obstétrico
								UPSS Centro quirúrgico		UPSS Centro quirúrgico
								UPSS Unidad de cuidados intensivos		UPSS Unidad de cuidados intensivos
ATENCIÓN DE SOPORTE	Atención con medicamentos			UPSS Farmacia				UPSS Farmacia	UPSS Farmacia	UPSS Farmacia
	Toma de muestra de sangre o fluidos corporales		UPSS Patología clínica	UPSS Patología clínica				UPSS Patología clínica	UPSS Patología clínica	UPSS Patología clínica
				Ecografía	UPSS			UPSS Diagnóstico por imágenes	UPSS Diagnóstico por imágenes	UPSS Diagnóstico por imágenes
				Radiología						
	Nutrición integral				UPSS Nutrición y dietética	UPSS Nutrición y dietética	UPSS Nutrición y dietética	UPSS Nutrición y dietética	UPSS Nutrición y dietética	UPSS Nutrición y dietética
	Rehabilitación basada en la comunidad				UPSS Medicina de rehabilitación	UPSS Medicina de rehabilitación		UPSS Medicina de rehabilitación		UPSS Medicina de rehabilitación
	Desinfección y esterilización				UPSS Central de esterilización	UPSS Central de esterilización		UPSS Central de esterilización		UPSS Central de esterilización
					UPSS Centro de hemoterapia y banco de sangre	UPSS Centro de hemoterapia y banco de sangre		UPSS Centro de hemoterapia y banco de sangre		UPSS Centro de hemoterapia y banco de sangre
					Diálisis	Diálisis		UPSS Hemodiálisis		UPSS Hemodiálisis
					Anatomía patológica	UPSS Anatomía patológica		UPSS Anatomía patológica		UPSS Anatomía patológica
								UPSS Radioterapia		

Lectura de la fuente. Se conservan las denominaciones del mapa de 2014. Los espacios vacíos no equivalen a una prohibición del servicio.

conservan sus licencias

02

Redes, información y recursos

La continuidad depende de rutas claras, información segura y recursos disponibles en el momento adecuado.

EN ESTE RECORRIDO

07 Referencia y contrarrefer

09 Redes Integradas de Salu

11 Recursos humanos en salud

OBJETIVO DEL CAPÍTULO

Revisa la ruta, explica cada tema con tus palabras y después practica con casos.

conservan sus licencias

TEMA 07 · EJE 05

Referencia y contrarreferencia

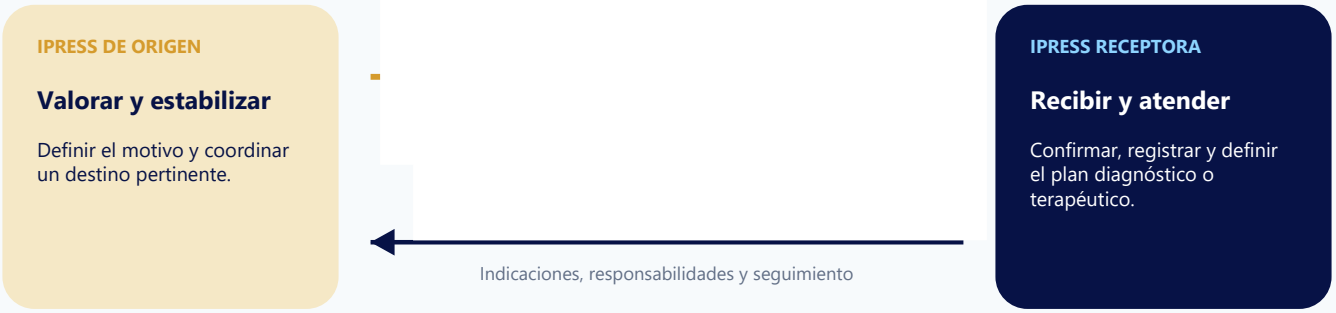
Hay una referencia cuando el caso supera la capacidad disponible y otro servicio asume temporalmente la responsabilidad asistencial. La contrarreferencia devuelve al establecimiento de origen la información, las indicaciones y las responsabilidades necesarias para continuar el cuidado. Sin coordinación previa, registro suficiente y seguimiento, el traslado no garantiza continuidad.

CONCEPTOS QUE SOSTIENEN EL TEMA

Referencia
Traslado coordinado de una persona hacia un servicio con mayor capacidad resolutiva o competencia necesaria.

Contrarreferencia
Retorno de información y continuidad del cuidado hacia el establecimiento de origen.

LA CONTINUIDAD E



La responsabilidad se transfiere; la continuidad se comparte.

LECTURA Y PRECISIONES DEL ESQUEMA

Momento	Responsabilidad	Documento/acción
Antes	Valorar, estabilizar y coordinar	Motivo y destino pertinente
Durante	Transferir información suficiente y segura	Formato y comunicación clínica
Recepción	Confirmar, atender y registrar	Plan diagnóstico/terapéutico
Retorno	Devolver indicaciones al origen	Contrarreferencia y seguimiento

conservan sus licencias

Condición de la persona contrarreferida

Concepto	Cómo reconocerlo	No confundir
Curado / mejorado	Curado: resuelto el motivo de referencia. Mejorado: resolución parcial y continuidad del tratamiento en origen.	Mejoría no implica alta definitiva.
Apoyo diagnóstico	Se obtuvieron los resultados o informes solicitados.	Completar una prueba no equivale a curación.
Retiro voluntario	La persona decide interrumpir y deja constancia conforme al procedimiento.	No confundir con abandono sin ese trámite.
Deserción	Interrupción o abandono pese a esfuerzos por localizar y retomar tratamiento.	Registrar acciones realizadas; no usar una etiqueta para omitir seguimiento.
Fallecido	Co dad informativa también incluye inf l episodio. es	

Fuentes de esta ampliación: [F] MINSA · N

ANCLAS PARA REC

01
Estabilizar primero si exist a pertinente y legible.
comunicar con el receptor.

03
Confirmar recepción y segui

CLAVE DE EXAMEN **Referencia sin contrarreferencia rompe la continuidad.**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicología y bibliografía institucional vinculada.

conservan sus licencias

Referencia y contrarreferencia

La continuidad exige información de ida y de retorno.

La referencia responde a una necesidad de atención que requiere capacidad resolutiva disponible en otro establecimiento. El retorno organiza la continuidad del cuidado.

ESTABLECIMIENTO DE ORIGEN

Evalúa la necesidad y su capacidad resolutiva.

IDA →

ESTABLECIMIENTO RECEPTOR

Recibe, evalúa y brinda la atención requerida.

REFERENCIA · LO QUE VIAJ

Coordinar el destino y el traslad
realizada y los documentos que

clínica relevante, la atención

CONTRARREFERENCIA · LO Q

Devolver la responsabilidad del cuidado o los resultados diagnósticos al origen o al establecimiento de procedencia que pueda continuar la atención. Comunicar el estado, lo realizado y el plan de seguimiento.

← RETORNO Y SEGUIMIENTO

En una emergencia, las gestiones administrativas no deben retrasar la atención necesaria. La ruta concreta depende del caso y de la red de servicios.

REPASO ACTIVO

Se atendió a la persona, pero el origen no recibió indicaciones para continuar.

El circuito de información y continuidad está incompleto: falta asegurar la contrarreferencia.

MINSA · NT 018-MINSA/DGSP-V.01, RM 751-2004: referencia y contrarreferencia. Síntesis

conservan sus licencias

Historia clínica

Es un documento asistencial y legal que registra atención de forma cronológica, veraz, pertinente y confidencial.

Archivo, identificación y acceso

Concepto	Cómo reconocerlo	No confundir
Archivo activo	Historias de quienes recibieron atención en los últimos 5 años, contados desde la última atención.	Al superar el periodo sin atención, corresponde el traslado según norma.
Archivo pasivo	Historias de fallecidos y de usuarios si co	No destruir automáticamente: interviene el nto archivístico y sus excepciones.
Identificación	Us co a do	s y verificar identidad antes
Custodia y acceso	La us inf	nal no autoriza divulgar echos de acceso.
Copia solicitada	La 5 día el pr	ra hábiles si la disposición ece.

Fuentes de esta ampliación: [H] MINSA · NTS 139: gestión de la historia clínica

HISTORIA ELECTRÓNICA E INFORMATIZADA

• Historia clínica electrónica (HCE): registro individual, unificado y multimedia, con valor asistencial y legal, refrendado mediante firma digital del profesional de salud. El sistema debe proteger autenticidad, integridad, confidencialidad, conservación y disponibilidad de la información.

• Historia clínica informatizada: información registrada y gestionada mediante soporte informático que, según la definición de la NTS 139, no cuenta con firma digital.

Digitalizar hojas, escribir en una computadora o guardar un PDF no acredita por sí solo una HCE. La firma identifica y vincula al profesional con el registro; las garantías del sistema permiten conservarlo, consultarlo y verificar su integridad.

Fuentes: [R038] RM N.° 214-2018/MINSA (13/03/2018), NTS N.° 139-MINSA/2018/DGAIN, numerales 5.1 y 5.2.1; modificada por RM 265-2018/MINSA · [R039] DS N.° 020-2025-SA (28/11/2025), modificación del Reglamento de la Ley 30024 aprobado por DS 009-2017-SA

conservan sus licencias

ELEGIR EL FORMATO

Los formatos básicos de historia clínica distinguen consulta externa, emergencia, hospitalización y ficha familiar. En consulta externa del primer nivel con población asignada, la NTS 139 dispone formatos por etapa de vida, para recoger las necesidades y contenidos correspondientes.

Primero identifica el ámbito de atención; después, la etapa de vida y los formatos complementarios necesarios. Un formulario genérico o la ficha familiar no sustituye el registro individual de la atención efectivamente realizada.

Fuentes: [R038] RM N.° 214-2018/MINSA (13/03/2018), NTS N.° 139-MINSA/2018/DGAIN, numerales 5.1 y 5.2.1; modificada por RM 265-2018/MINSA

ANCLAS PARA RECORDAR

01	Diferenciar información referida, hallazgo, interpretación y plan; el diagnóstico debe consignarse de forma clara y sin abreviaturas ambiguas.
02	Toda atención realizada debe quedar registrada en la historia clínica. Abrir o identificar el expediente no equivale a registrar el acto asistencial: deben constar la evaluación, las decisiones, el pla
03	En menores de e derado y las autorizaciones qu madurez.
04	Corregir según pr
05	Acceso sujeto a a

CLAVE DE EXAMEN **Lo n**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicología

Fuentes: [R038] RM N.° 214-2018/MINSA (13/03/2018), NTS N.° 139-MINSA/2018/DGAIN, numerales 5.1 y 5.2.1; modificada por RM 265-2018/MINSA

conservan sus licencias

TEMA 09 · EJE 05

Redes Integradas de Salud

Las RIS coordinan establecimientos y otros actores de un territorio para que la atención sea continua, integral y centrada en las personas.

ANCLAS PARA RECORDAR

01	Población y territorio definidos, primer nivel fortalecido y gobernanza común.
02	El equipo multidisciplinario del primer nivel actúa como puerta de entrada y mantiene responsabilidad por la continuidad, aun cuando coordine una referencia.
03	Rutas asistenciales, intercambio de información y soporte entre niveles.
04	Medir continuida islada.

CLAVE DE EXAMEN **Una dinación funcional con resp**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicol

conservan sus licencias

Telesalud

Comprende servicios a distancia para atención, gestión, información, educación y fortalecimiento de capacidades.

NO TODA INTERACCIÓN REMOTA ES LO MISMO: RECONOCE LA MODALIDAD EN EL CASO

Modalidad	Finalidad	Ejemplo breve	Cuidado
Teleconsulta	Atención entre profesional y persona usuaria.	Una psicóloga evalúa y orienta a una persona mediante videollamada institucional.	Pertinencia clínica, consentimiento, privacidad y registro.
Teleinterconsulta	Consult profesio apoyar	nsulta	Responsabilidades claras y respuesta documentada.
Teleorientación	Informa inicial si atenció		No convertir orientación en diagnóstico o tratamiento incompleto.
Telecapacitación	Fortalec compet persona		Definir objetivo y evaluar el aprendizaje.

ANCLAS PARA RECOR

01
Telemedicina requiere pertinencia clínica, identificación, consentimiento y privacidad.

02
Teleorientación informa y guía; no reemplaza evaluación cuando esta es necesaria.

03
La telecapacitación fortalece competencias del personal mediante actividades educativas a distancia; no es una consulta clínica a la persona usuaria.

04
Prever contingencia tecnológica, registro y derivación.

CLAVE DE EXAMEN **La modalidad remota no reduce los estándares éticos, clínicos ni de seguridad.**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicología y bibliografía institucional vinculada.

conservan sus licencias

Transferir información y responsabilidad sin perder continuidad

Una derivación o atención remota necesita un cierre verificable. Handoff es una herramienta de comunicación, no un sustituto del formato normativo de referencia.

Momento	Información o verificación
Identificar	Quién es la persona, quién entrega y quién recibe; confirmar canales autorizados.
Situación y antecedentes	Motivo actual, evolución relevante, intervenciones realizadas y riesgos prioritarios.
Valoración y necesidad	Qué se ha observado, qué falta evaluar y por qué se solicita apoyo.
Recomendación y acuerdo	Acción requerida, urgencia, responsable y oportunidad para preguntas.
Cerrar el circuito	Confirmar recepción, documentar indicaciones y acordar seguimiento.

EN TELESALUD

Verificar consentimiento, ident actar o activar ayuda ante una urgencia. Acordar qué hac el encuentro.

La teleinterconsulta vincula prof ria. Si el profesional pide opinión a otro durante el cuidad iones independientes. Precisar roles y registro según la

CASO APLICADO

Enviar un archivo no acredita rec ndo el receptor comprende la solicitud, asume lo acordado y el origen dispone de información para continuar.

Marco peruano: NTS 235-MINSA/DIGTEL/2025, aprobada por RM 664-2025-MINSA. Distingue teleconsulta y teleinterconsulta; comprobar además los requisitos operativos de la prestación y del servicio.

Fuentes: [N19], [N26].

conservan sus licencias

TEMA 11 · EJE 05

Recursos humanos en salud

Gestionar personas incluye planificación, selección, inducción, competencias, desempeño, bienestar y distribución equitativa.

UBICA EL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS

• Gestión del empleo: incluye incorporación e inducción.

• Gestión del rendimiento: comprende evaluación del desempeño.

• Gestión de la compensación: administra compensaciones.

• Gestión de relaciones humanas y sociales: incluye relaciones laborales, seguridad y salud en el trabajo, bienestar social, cultura y clima organizacional, y comunicación interna.

La prevención de riesgos labor bajo. No se clasifica como inducción o evaluación del des o medición de resultados.

Fuentes: [R045] RPE N.° 238-2014-SERVIR- s del SAGRH · [R041] RPE N.° 150-2017-SERVIR-PE (24/08/2017), Guía p 3.3 · [R046] SERVIR, Inducción a la Gestión del Rendimiento, esquema El SAG

CONTAR ACTIVIDA

Producción es el volumen reali ductividad se relaciona un producto con un recurso defin

• Productividad hora-profesio

• Rendimiento hora-profesional: ajadas.

Ejemplo: 80 consultas, 40 horas p por hora, respectivamente. Deben coincidir profesional, servicio y periodo del numerador y denominador.

Siempre revisa la ficha técnica: los nombres varían entre sistemas. Un número aislado de consultas no permite calcular un cociente ni evaluar por sí solo calidad o desempeño.

Fuentes: [R043] Hospital San Juan Bautista de Huaral / Hospital Huaral y SBS, Equipo Técnico de Estadística e Informática, Producción de Servicios 2022 - Anual (reporte 26/01/2023), tabla Indicadores hospitalarios, indicadores1-2; ejemplo institucional, no norma nacional · [R044] EsSalud, Informe de evaluación POI, I trimestre 2026, apartado 4.5.5, rendimiento hora-médico

conservan sus licencias

ANCLAS PARA RECORDAR

01	Brecha combina cantidad, perfil, ubicación y condiciones de trabajo.
02	El control de asistencia verifica cumplimiento de jornada y horario; no reemplaza la evaluación de desempeño ni la medición de productividad.
03	Capacitación debe responder a una necesidad y evaluar aplicación.
04	Supervisión formativa mejora práctica; no es solo control.

CLAVE DE EXAMEN **Más personal no siempre resuelve una brecha si el perfil o la distribución son inadecuados.**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicología y bibliografía institucional vinculada.

conservan sus licencias

Inventario y stock

La disponibilidad requiere programación, adquisición, almacenamiento, control y reposición con trazabilidad.

ROTACIÓN Y REPOSICIÓN

Regla	Orden	Cuándo usar
FEFO	Primero vence, primero sale	Productos con fecha de caducidad
FIFO	Primero ingresa, primero sale	Bienes sin prioridad por vencimiento
Punto de reposición	Demanda esperada durante el pl se	Evitar quiebre de stock
Stock de seguridad	Re	re razonable

PRODUCTO VENCID R

1. Retirarlo de dispensación y ustodia.
2. Comunicar al responsable y onforme al procedimiento.
3. Tramitar el acopio y el infor etentes para la baja formal.
4. Ejecutar la disposición final por tal.

Avisar al responsable inicia la ges destruir, donar o devolver informalmente el producto. La baja administrativa y la destrucción física son actos diferentes. El circuito busca evitar reutilización, exposición y pérdida de trazabilidad.

Fuentes: [R056] Oficio Múltiple N.° 064-2026-DIGEMID-DG-DFAU-EAM/MINSA (16/01/2026); remite a RM019-2020/MINSA y DA249/SISMED

conservan sus licencias

ANCLAS PARA RECORDAR

01	Stock mínimo, máximo y punto de reposición previenen quiebres y sobrestock.
02	FEFO prioriza lo que vence primero; FIFO lo que ingresó primero.
03	En una contratación, el área usuaria formula el requerimiento y sustenta la necesidad; el órgano encargado conduce las actuaciones de abastecimiento según sus competencias.
04	Registrar consumo, pérdidas, vencimientos y condiciones de almacenamiento.

CLAVE DE EXAMEN **Para productos con caducidad, prioriza FEFO.**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicología y bibliografía institucional vinculada.

Fuentes: [R057] WFP / Global Logistics Cluster, Logistics Operational Guide, Managing Inventory Levels; consulta19/10/2026

conservan sus licencias

Stock: calcular y revisar supuestos

Los cálculos orientan la decisión; el sistema institucional y sus reglas determinan la programación y autorización. Ejemplo didáctico, sin pauta de compra real.

Dato	Valor del ejemplo
Consumo medio mensual	120 unidades
Plazo esperado de reposición	2 meses
Stock de seguridad definido para el ejercicio	60 unidades
Punto de reposición	120 × 2 + 60 = 300 unidades

Si la disponibilidad utilizable alcanza 300 unidades, debe activarse la reposición según el procedimiento y considerando pedidos en tránsito y compromisos. No confundir punto de reposición con cantidad a comprar; esta también depende del nivel

Control	
FEFO	iento posterior mientras
Registro por lote y fecha	
Segregar vencidos o no conform	ensen.
Revisar consumo y demoras	zca quiebres o sobrestock.

CASO APLICADO

Hay 400 unidades físicas, pero 150 están vencidas. La existencia física no equivale a disponibilidad utilizable: son 250, antes de revisar otras reservas o restricciones. No destruir ni donar fuera del procedimiento autorizado.

Fuentes: [N24].

conservan sus licencias

03

Personas, liderazgo y calidad

Los resultados dependen de alianzas, equipos, cultura y aprendizaje continuo.

EN ESTE RECORRIDO

13 **Alianzas intersectoriales en equipo**

15 **Calidad y seguridad del p anizacional**

OBJETIVO DEL CAPÍTULO

Revisa la ruta, explica cada tema con tus palabras y después practica con casos.

conservan sus licencias

TEMA 13 · EJE 05

Alianzas intersectoriales

Una alianza efectiva define propósito, aportes, gobernanza, comunicación, compromisos e indicadores compartidos.

ANCLAS PARA RECORDAR

01	Mapear interés, influencia, recursos y riesgos de actores.
02	Formalizar acuerdos cuando corresponda.
03	Revisar cumplimiento y resolver conflictos de manera transparente.

CLAVE DE EXAMEN **Coo com** **oducto y responsabilidad**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicol

conservan sus licencias

TEMA 14 · EJE 05

Liderazgo y trabajo en equipo

El liderazgo orienta propósito, facilita decisiones y desarrolla capacidades; el equipo coordina roles interdependientes.

ANCLAS PARA RECORDAR

01	Claridad de roles, metas, comunicación y seguridad psicológica.
02	Liderazgo situacional adapta apoyo y dirección a competencia y tarea.
03	Conflicto gestionado puede mejorar decisiones; ocultarlo las deteriora.

CLAVE DE EXAMEN **Un** **arte objetivo, roles y** **resp**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicol

conservan sus licencias

TEMA 15 · EJE 05

Calidad y seguridad del paciente

La calidad se valora por la efectividad, la oportunidad, la equidad, la eficiencia, la seguridad y la atención centrada en la persona. Cuando ocurre un incidente, la seguridad del paciente exige atender el daño, reportar lo sucedido, buscar las causas del sistema y aplicar mejoras. Señalar a una persona sin corregir el proceso deja intacto el riesgo de repetición.

MEDIR Y MEJORAR SIN PERDER EL FOCO

Marco	Pregunta	Ejemplo
Estructura	¿Con qué recursos contamos?	Personal, ambientes y equipos
Proceso	¿C	nto de protocolo
Resultado	¿Q ex	ento adverso o satisfacción
PHVA	¿C	erificar y actuar

AUDITORÍA DE LA C

La auditoría contrasta la atenci e mejora y proteger derechos.

• Según quién la realiza: inter instancia ajena a este, dispuesta según competencia.

• Según programación: programada o de caso. La auditoría de caso examina una atención particular ante un incidente o evento adverso; una muerte materna o perinatal requiere valorar esa atención, no limitarse a contar fallecimientos.

La clasificación depende del criterio preguntado. Una auditoría de caso puede ser interna o externa. Su finalidad de mejora no equivale a establecer responsabilidades médico-legales ni a imponer sanciones.

Fuentes: [R040] RM N.° 502-2016/MINSA (15/07/2016; ficha SUSALUD 18/07/2016), NTS N.° 029-MINSA/DIGEPRES-V.02, 5.4-5.8, 5.17-5.18 y 6.3

conservan sus licencias

ANCLAS PARA RECORDAR

01	Ciclo PHVA: planificar, hacer, verificar y actuar.
02	Analizar incidentes para corregir sistemas, no solo culpar individuos.
03	Indicadores de estructura, proceso y resultado muestran dimensiones distintas.
04	La auditoría tiene cinco etapas: planeamiento → ejecución → informe final → implementación de recomendaciones → seguimiento. Implementar es ejecutar las medidas preventivas o correctivas. En el seguimiento, la unidad responsable de calidad acuerda con los involucrados el plan de implementación, concreta objetivos, metas, plazos y responsabilidades, y verifica avances con evidencia. Recibir un informe o aprobar un plan no demuestra que la mejora se haya realizado.
05	Si cambia la capacidad resolutiva de una IPRESS, corresponde evaluar la actualización de su cartera y el proceso de categorización o recategorización, no asumir el cambio automáticamente.
06	La NTS 249 debe

CLAVE DE EXAMEN **Un** **del** **rte, análisis y mejora**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicol

Fuentes: [R040] RM N.° 502-2016/MINSA (RES-V.02, 5.4-5.8, 5.17-5.18 y 6.3

conservan sus licencias

PHVA: la mejora necesita una medición antes y después

La imagen representa un ciclo de mejora. Se aplica a un proceso definido y se repite con aprendizaje.



Jsmura · CC BY-SA 4.0. Sin recorte; escala propo

Fuente

DIFERENCIA QUE IMPORTA

Capacitar al personal es una actividad. Demostrar que mejoró la continuidad requiere datos comparables. Si no mejora, revisar barreras y ejecución; no concluir automáticamente que el personal «no se compromete».

Fase	Eje
Planificar	De dor de continuidad.
Hacer	Aplica jecutó.
Verificar	Comp no deseados.
Actuar	Ajustar, estandarizar si corresponde o replantear; volver a medir.

Fuentes: [N18], [N20].

conservan sus licencias

TEMA 16 · EJE 05

Clima y cultura organizacional

Clima es la percepción actual del entorno laboral; cultura son valores, supuestos y prácticas más profundas y estables.

CONCEPTOS QUE SOSTIENEN EL TEMA

Clima
Percepción compartida y más cambiante sobre cómo se vive el trabajo en la organización.

Cultura
Valores, supuestos y prácticas profundas que orientan cómo actúa la organización.

SE RELACIONAN, PERO NO SON EQUIVALENTES

Concepto	Pr	serva
Clima	Pe	derazgo, carga y
Cultura	Su	los y prácticas repetidas
Intervención	Co	azgo y seguimiento

GESTIÓN DEL CLIM

1. Planificación: adecuar la encue ición.
2. Intervención: medir, elaborar e r y ejecutar el plan de acción.
3. Evaluación: comprobar cumplimiento y efectividad del plan.

La adecuación del cuestionario ocurre antes de recoger las respuestas. Medir sin comunicar ni actuar deja el proceso incompleto; ejecutar actividades sin evaluar sus efectos tampoco basta.

Identifica el marco: esta secuencia corresponde a SERVIR. La metodología MINSA de 2011 es otro marco; no deben mezclarse denominaciones de documentos diferentes.

Fuentes: [R041] RPE N.° 150-2017-SERVIR-PE (24/08/2017), Guía para la Gestión del Proceso de Cultura y Clima Organizacional, sección 3.3 · [R042] RM N.° 468-2011/MINSA (14/06/2011), Metodología para el Estudio del Clima Organizacional V.02

conservan sus licencias

ANCLAS PARA RECORDAR

01
Medir clima permite identificar comunicación, liderazgo, reconocimiento y carga.

02
La cultura se observa en decisiones y conductas repetidas, no solo declaraciones.

03
Intervenir requiere participación, liderazgo coherente y seguimiento.

CLAVE DE EXAMEN **Clima cambia más rápido; cultura es más profunda y resistente.**

Fuente: Temario oficial MINSA para Psicología y bibliografía institucional vinculada.

conservan sus licencias

Seguridad, liderazgo y cultura: aprender del proceso

Una respuesta justa busca proteger a las personas, comprender el sistema y actuar conforme a las responsabilidades aplicables.

Situación	Qué estudiar
Falla detectada antes de llegar a la persona	Es una oportunidad para aprender de barreras que funcionaron y de riesgos que siguen presentes.
Incidente que llega sin daño	Que no haya daño no elimina la necesidad de analizar el riesgo.
Daño relacionado con la atención	Atender necesidades inmediatas, comunicar y reportar por la vía institucional; investigar causas y aplicar mejoras.
Repetición de errores	Revisar carga, ambiente, coordinación, información, diseño de tareas y
Cultura y clima	nan con cultura; percepciones mbos con seguimiento.

CASO APLICADO

El equipo evita reportar por te del error» no basta: se necesitan canales, protección ejora verificables.

Una auditoría de calidad no equi stigación penal. Pueden coexistir procesos con objetivos y c para hablar no elimina rendición de cuentas ni el debido p

Fuentes: [N20], [N19].

conservan sus licencias

EJE 05 · CIERRE DE REPASO

Lo que debes poder explicar

Si una idea todavía no sale con tus propias palabras, vuelve al tema antes de practicar.

01 **Regla temporal: PEI 5 años, POI Multianual 3 y POI Anual 1.**

02 **La categoría expresa capacidad resolutiva; la UPSS organiza una producción específica de servicios.**

03 **Referencia traslada responsabilidad de manera coordinada; contrarreferencia devuelve información y continuidad.**

04 **Las RIS integran prestaciones y niveles alrededor de necesidades territoriales.**

05 **Calidad exige medir, interv**

NO LOS CONFUNDAS

PEI / POI

ROF / MOP

n funciones

Clima / cultura

Percepción del ambiente / supuestos y prácticas compartidas

RECUERDA SIN MIRAR

1. **¿Qué instrumento traduce objetivos estratégicos en actividades anuales?**
2. **¿Qué diferencia una categoría de establecimiento de una UPSS?**
3. **¿Qué información debe retornar mediante la contrarreferencia?**

conservan sus licencias

Practica y comprueba

Casos originales . Responde antes de leer la explicación. La mención de una clave histórica se identifica expresamente.

CASO 01 · ORIGINAL

Una IPRESS amplía su capacidad resolutiva antes de cumplir tres años. ¿Debe esperar?

Respuesta razonada. Corresponde valorar recategorización anticipada según el cambio y el procedimiento. El plazo regular no bloquea esa evaluación.

CASO 02 · ORIGINAL

La persona retorna con mejoría parcial y un plan de control. ¿Curado o mejorado?

Respuesta razonada. Mejorado. Se mantiene la continuidad del tratamiento; no confundir con solución definitiva del motivo de refere

CASO 03 · ORIGINA

El archivo conserva una histo estruirla?

Respuesta razonada. No. Corre onservación, transferencia y eventual eliminación autoriz

conservan sus licencias

Fuentes de referencia

[T] MINSA · Temario de Psicología SERUMS 2026-II

Contenidos temáticos por carrera; publicación del 22/07/2026.

[E] MINSA · Cuadernillo oficial Psicología 2026-II

Preguntas 1, 4, 14, 21, 26, 28, 40, 46, 50, 52, 76 y 87. Claves históricas conservadas.

[G] DIRESA Tacna · Recategorización

Regla de tres años o variación de complejidad. No se traslada el plazo excepcional de 2023.

[F] MINSA · NT 018: referencia y contrarreferencia

RM 751-2004; numeral 9.3, condiciones de contrarreferencia.

[H] MINSA · NTS 139: gestión de la historia clínica

Numerales 4.1, 4.2 y gestión de archivos; pp. 13, 37 y anexo de apertura con DNI del PDF.

Documentos consultados

[R038] RM N.□ 214-2018/MI 018/DGAIN, numerales 5.1 y 5.2.1; modificada por RM 265

PDF oficial leído en los apartados de defin extrapolan los contenidos de cada formato.

[R039] DS N.□ 020-2025-SA (Ley 30024 aprobado por DS 009-2017-SA

Decreto modificatorio completo. Actualiza almacenamiento informático sin firma digital en HCE según NTS139.

[R040] RM N.□ 502-2016/MI TS N.□ 029-MINSA/DIGEPRES-V.02,

Documento completo descargado y texto cot nto son etapas distintas.

[R041] RPE N.□ 150-2017-SERVIR-PE (24/08/2017), Guía para la Gestión del Proceso de Cultura y Clima Organizacional, sección 3.3

Guía completa descargada; sección 3.3 y esquema de fases leídos. Los considerandos también identifican los procesos de relaciones humanas y sociales.

[R042] RM N.□ 468-2011/MINSA (14/06/2011), Metodología para el Estudio del Clima Organizacional V.02

Ficha oficial de aprobación y publicación verificada. La descarga integral de este PDF no estuvo disponible; se omiten el número de etapas y sus detalles. No se afirma derogación por la guía SERVIR.

[R043] Hospital San Juan Bautista de Huaral / Hospital Huaral y SBS, Equipo Técnico de Estadística e Informática, Producción de Servicios 2022 - Anual (reporte 26/01/2023), tabla Indicadores hospitalarios, indicadores1-2; ejemplo institucional, no norma nacional

PDF completo descargado y tabla Indicadores hospitalarios cotejada: productividad usa horas programadas; rendimiento usa horas efectivas. Solo ejemplifica el uso de horas programadas frente a efectivas; el nombre del indicador exige revisar su ficha.

[R044] EsSalud, Informe de evaluación POI, I trimestre 2026, apartado 4.5.5, rendimiento hora-médico

Cotejo de uso actual del denominador horas efectivas. No se añaden valores meta ni se trasladan metas médicas a psicología.

[R045] RPE N.□ 238-2014-SERVIR-PE (10/11/2014), Directiva N.□ 002-2014-SERVIR/GDSRH, subsistemas del SAGRH

conservan sus licencias

Ficha aprobatoria verificada. La descarga de este alojamiento no se logró leer íntegramente; el contenido incorporado se limita a la clasificación corroborada en fuentes oficiales de SERVIR, incluida RPE150-2017 y su guía.

[R046] SERVIR, Inducción a la Gestión del Rendimiento, esquema El SAGRH y la Gestión del Rendimiento

Esquema oficial indexado leído; ubica inducción, evaluación del desempeño, compensación y SST en los subsistemas señalados, con referencia expresa a Directiva002-2014.

[R047] Directiva N.□ 001-2024-CEPLAN/PCD, aprobada por RPC021-2024 y modificada por RPC039-2024 (30/04/2024), art. 13.2

Artículo 13.2 leído. La secuencia vigente explicita análisis prospectivo en fase 2 y decisión estratégica en fase 3.

[R048] RPC N.□ 055-2024/CEPLAN/PCD (13/06/2024), Guía para el Planeamiento Institucional actualizada

Aprobación de guía verificada. Se conserva la explicación PEI/POI ya incluida en el compendio.

[R049] RPC N.□ 057-2025/CEPLAN/PCD (25/06/2025), modificación de la Directiva001-2024

Modificación oficial revisada: artículo 16.3, capítulo X y disposición transitoria; no sustituye el artículo 13.2 utilizado.

[R056] Oficio Múltiple N.□ 064-2026-DIGEMID-DG-DFAU-EAM/MINSA (16/01/2026); remite a RM019-2020/MINSA y DA249/SISMED

Oficio oficial completo de tres páginas leí trimonial y disposición final por operador autorizado.

[R057] WFP / Global Logistics aging Inventory Levels; consulta19/10/2026

Texto oficial indexado leído: buffer = cons orado con glosario oficial https://log.logcluster.org/en/inventory-pla ruana ni regla única para todo sistema de revisión.

[R058] RM N.□ 546-2011/MI .03, categoría I-4, pp.29-30 del anexo

PDF descargado y cotejo de personal míni ba que un I-3 tenga prohibido contar con psicólogo.

[R059] RM N.□ 625-2026/MINS

Cuerpo completo de la resolución leído; el títu M625 y su texto. Art.2 crea Repositorio Nacional; art.5 cambia la denominación a Sub UPSS en NTS021. Anexo NTS249 no leído íntegramente; no se altera el desarrollo de cartera ya existente.

conservan sus licencias

Índice de temas

Tema	Página
01 Planeamiento estratégico y marco legal	4
02 Misión, visión, valores y FODA	5
03 PEI y POI	6
04 ROF, MOP y organización funcional	9
05 Categorías de establecimientos	11
06 UPSS y cartera de servicios	14
07 Referencia y contrarreferencia	19
08 Historia clínica	22
09 Redes Integradas de Salud	24
10 Telesalud	25
11 Recursos humanos en salud	27
12 Inventario y stock	29
13 Alianzas intersectoriales	33
14 Liderazgo y trabajo en equip	34
15 Calidad y seguridad del pacient	35
16 Clima y cultura organizacional	38

conservan sus licencias

Referencias

[N18] CEPLAN. Guía para la elaboración de indicadores, 2024

Documento de referencia

[N19] AHRQ. TeamSTEPPS: Handoff

Documento de referencia

[N20] AHRQ. System-Focused Event Investigation and Analysis Guide

Documento de referencia

[N21] MINSA. Contenidos temáticos oficiales SERUMS 2026-II, Psicología

Documento de referencia

[N24] USAID. The Logistics Handbook, capítulo 4: sistemas de control de inventario

Documento de referencia

[N26] MINSA. NTS 235-MINSA/DIGTEL/2025, Norma Técnica de Salud en Telesalud. RM 664-2025-MINSA, definiciones 5.1 kk y tt

Documento de referencia

Créditos de imágenes

Ciclo PHVA.png

Jsmura. CC BY-SA 4.0. Sin modificaciones;

Fuente

Licencia y condiciones

. Las imág ón no implica aval de sus autores.

conservan sus licencias